Characterological Diagnostic Questionnaire Report

03 вересня 2025 | Зазулін Олесь

I. Вступ

Метод патохарактерологічного дослідження, відомий як Патохарактерологічний Діагностичний Опитувальник (ПДО), призначений для визначення типів акцентуацій характеру та типів психопатій, а також деякі інші особистісні особливості, такі як психологічна схильність до алкоголізму, делинквентного поведінки, дисимуляції рис свого характеру та системи своїх особистісних відносин, підвищеної відвертості, співвідношення рис мужності-фемінності в системі особистісних відносин.

Спеціальні додаткові шкали призначені для оцінки схильності до депресії, ризику соціальної дезадаптації, можливості формування психопатій (розладів особистості), ризику зловживання наркотиками та іншими наркотичними засобами, диференційної діагностики справжніх та демонстративних спроб самогубства у підлітків.

Тип акцентуації вказує на слабкі місця та особливості характеру і тим самим дозволяє передбачити фактори, що можуть викликати психогенні реакції, що призводять до дезадаптації, — таким чином, відкриваються перспективи для психопрофілактики та корекції поведінкових патернів.

II. Визначення

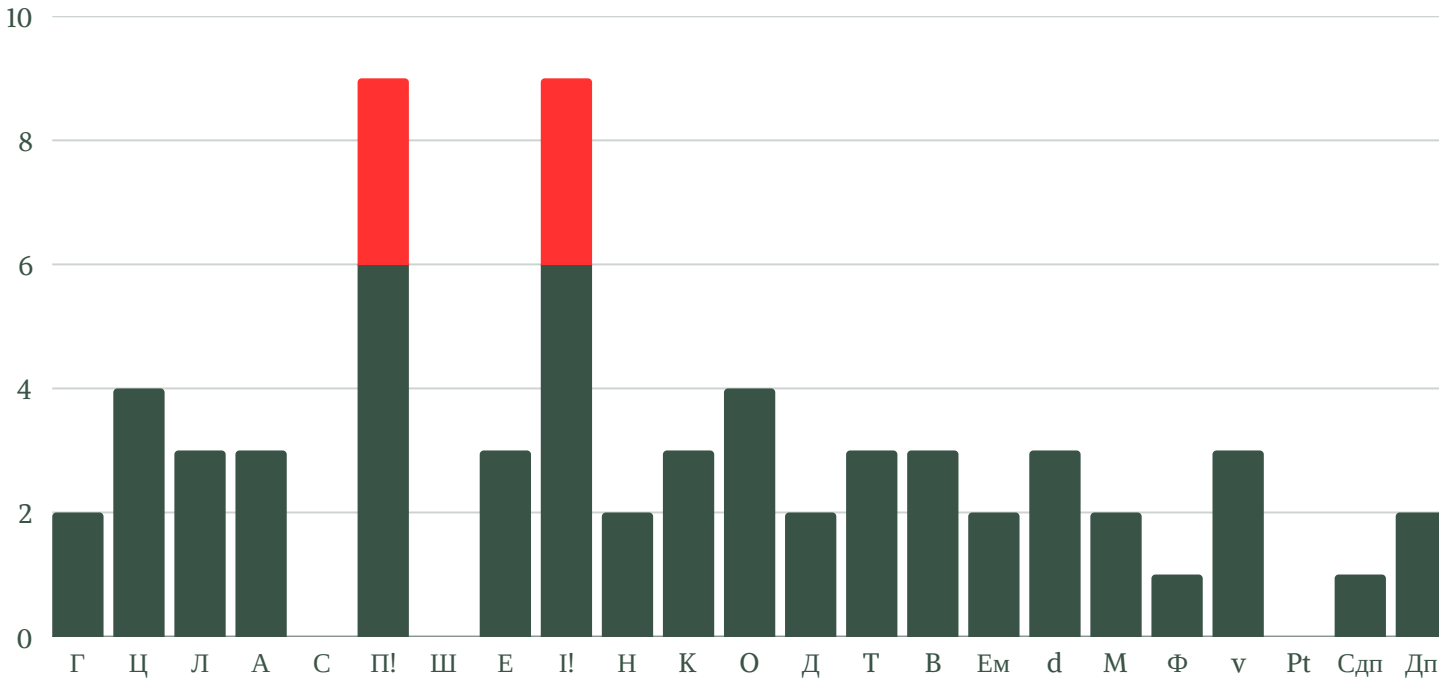
Визначення ключових термінів, пов’язаних з ПДО, а також контекст для їх використання в документі.

Акцентуація	гранично виражені риси характеру, які є варіантом норми.
МДЧ	максимально допустиме число, при якому акцентуація не вважається вираженою.
B (brain minimal damage)	вказівка на можливу органічну природу психопатії та акцентуації характеру. (травми голови - МДЧ = 5 і більше, сильний стрес - МДЧ = 4)
Ф\М	Оцінка рис мужності-жіночності в системі відносин.
Реакція Емансипації	бажання втечі від контролю, опіки та нагляду.
d - Деліквентність	Оцінка схильності до злочинів. Здійснюється лише для підлітків чоловічої статі.
Д - дисимуляція	ситуація, коли індивід навмисно приховує свої психопатичні риси або акцентуації характеру. Це може бути зроблено з метою соціальної адаптації або для уникнення негативних наслідків, які можуть виникнути, якщо ці риси стануть відомими іншим.
v - алкоголізація	визначення психологічної схильності до алкоголізації
Сдп	соціальна дизадаптація
Дп	схильність до депресії
Місце найменшого спротиву	або "слабкі ланки" характеру, а також опис цих місць застосовано до кожного типу акцентуації. Слабкі місця кожного характеру треба знати, щоб уникати неправильних кроків, надмірних навантажень та ускладнень у сім'ї та на роботі, при вихованні дітей, організації власного життя.

К (конформність)	"Аморфний тип" характеру, позбавлений будь-яких індивідуальних рис: ці люди "пливуть за течією", сліпо підкоряються своєму оточенню.

III. Графік Акцентуацій

Максимальне допустиме число (МДЧ) Гіпертимної акцентуації становить - 7. Для Астено-Невротичної - 5. МДЧ для решти акцентуацій становить - 6. Акцентуація, що перевищує своє МДЧ вважається вираженою.



IV. Короткий Опис Діагностованих Типів

Гіпертимний тип (Г). З дитинства відрізняються великою гучністю, товариськістю, надмірною самостійністю, схильністю до витівок, недоліками відчуття дистанції у стосунках до дорослих. Люблять командувати в дитячих іграх. У підлітковому віці відрізняються майже завжди хорошим, навіть трохи підвищеним настроєм, високим життєвим тонусом та енергією, невгамовною активністю, постійним прагненням до лідерства, причому неформальному. Добре почуття нового поєднується з нестійкістю інтересів, а велика товариськість з невибагливістю у виборі знайомств. Легко можуть опинитися у неблагополучному оточенні, люблять ризик. Схильні до переоцінки своїх можливостей та надмірно райдужних планів на майбутнє. Реакція емансипації дуже сильна: рано прагнуть до самостійності та незалежності. Самооцінка зазвичай непогана, але часто намагаються показати себе більш конформними, ніж це є насправді.

Місце найменшого спротиву: Причиною обурення зазвичай є протидія з боку оточуючих, прагнення з їхнього боку занадто різко придушити бажання та наміри гіпертима, підпорядкувати його чужій волі. Іноді приводом для роздратування стає усвідомлення надто явних власних промахів та невдач. Спалахи роздратування та гніву частішають і посилюються в ситуації строго регламентованого дисциплінарного режиму, який гіпертими дуже погано переносять, а також коли вони опиняються на самоті, позбавлені товариства, широких контактів з однолітками, можливості кудись застосувати виринаючу з них енергію. Душевна напруга в поєднанні з вимушеним неробством переноситься погано. У закритому закладі, зі строгим режимом, обмеженням нових контактів та необхідністю багатоденного цілодобового спілкування закритого кола осіб, надто бурхлива енергія гіпертимів, їх постійне бажання всюди встрявати та всіма командувати починають тягарити однолітків, які втрачають до них симпатію. Реагуючи бурхливими спалахами на їхню ж нестриманість спровоковані протести інших людей, вони починають постійно створювати навколо себе грозову атмосферу і втрачають лідерську роль. Невгамовний інтерес до всього навколо робить гіпертимів невибагливими у виборі знайомств.

Циклоїдний тип (Ц). Зустрічаються лише у вигляді акцентуацій характеру. При патологічному рівні розвитку одна з форм прикордонного нервово-психічного розладу – циклотимія. У дитинстві не відрізняються від однолітків або справляють враження гіпертимів, але з настанням пубертатного періоду з'являється перша субдепресивна фаза, яка змінюється фазою гіпертимності. Тривалість періодів з віком змінюється: спочатку – дні та тижні, а потім вони збільшуються. У субдепресивній фазі падає працездатність, до всього втрачається інтерес, стають в'ялими домосідами, уникають компанії. Невдачі та навіть дрібні неприємності тяжко переживаються. Серйозні зауваження, особливо ті, що принижують самолюбство, здатні навести на думки про власну неповноцінність і непотрібність та підштовхнути до суїцидальної поведінки. У субдепресивній фазі також погано переносяться різка зміна стереотипів життя (переїзд, зміна навчального закладу і т.д.). У гіпертимній фазі циклоїди не відрізняються від гіпертимів. Кидаються в очі раніше не властиві їм ризиковані жарти над старшими і бажання скрізь і завжди гострити. Емансипаційні прагнення та групування з однолітками виходять на час підйомів і зазвичай виражені помірно. Самооцінка формується поступово з накопиченням досвіду «хороших» та «поганих» періодів. У підлітків вона часто буває ще неточною.

Місце найменшого спротиву: Серйозні невдачі та докори оточуючих можуть поглибити субдепресивний стан або викликати гостру афективну реакцію інтрапунітивного типу (скерування агресії або негативних емоції внутрішньо, на себе) з суїцидальними спробами. Зазвичай лише в цьому випадку циклоїди потрапляють у поле зору психіатра.

Лабільний тип (Л). У дитинстві за характером зазвичай не відрізняються від однолітків або виявляють схильність до невротичних реакцій. Часто хворіють «застудами», ревматизмом, пневмоніями, холециститами та іншими інфекційними захворюваннями, що мають затяжний і рецидивуючий перебіг. Головна риса у підлітковому віці – крайня мінливість

настрою, який змінюється занадто часто і надмірно різко від незначних і навіть непомітних для оточуючих приводів. Від настрою залежить і сон, і апетит, і працездатність, і товариськість. Почуття та прихильності щирі та глибокі, особливо до тих осіб, які самі проявляють любов, увагу та турботу. Велика потреба у співпереживанні. Тонко відчувають ставлення до себе навіть при поверхневому контакті. До лідерства не прагнуть, а шукають емоційні контакти, охоче задовольняються положенням опікуваного та захищеного іншими улюбленця. Важко переносять втрату або емоційне відкидання з боку значущих осіб. Емансипаційні прагнення виражені помірно. Їм добре в сім'ї, якщо там панує любов, тепло та затишок. Тоді емансипаційна активність обмежується короткими спалахами, пов'язаними з примхами настрою. Самооцінка відрізняється щирістю та вмінням правильно помітити риси свого характеру.

Місце найменшого спротиву: "Слабким місцем" даного типу є відкидання з боку емоційно значущих осіб, втрата близьких, примусова розлука з ними. Докори, засудження, догани, нотації глибоко переживаються і здатні занурити в безнадійне пригнічення. Дійсні неприємності, втрати, нещастя лабільні підлітки переносять надзвичайно важко, виявляючи схильність до гострих афективних реакцій, реактивних депресій, важких невротичних зривів.

Астено-невротичний (А). З дитинства часто виявляються ознаки невропатії – поганий сон і апетит, капризність, лякливість, сльозливість, іноді нічні страхи, нічний енурез, заїкання та ін. У інших випадках дитинство проходить благополучно і перші ознаки астено-невротичного типу виявляються лише у підлітковому віці. Основними рисами є підвищена втомлюваність, дратівливість, схильність до іпохондрії. Втомлюваність особливо проявляється в умовах розумових занять, фізичних та емоційних напружень. При втомленні афективні спалахи виникають з будь-якого приводу. Роздратування, легко виливається на оточуючих, іноді випадково потрапили під руку, легко змінюється каяттям і навіть сльозами. Звичайні підліткові порушення поведінки (делинквентність, алкоголізація та ін.) цьому типу не властиві. До однолітків тягнуться, шукають їх компанію, але швидко від неї втомлюються і віддають перевагу самотності або спілкуванню з близьким другом. Самооцінка зазвичай відображає іпохондричні налаштування, тобто турботи про своє здоров'я.

Місце найменшого спротиву: При цьому типі акцентуації підвищена чутливість до напружених розумових навантажень та подій, що провокують іпохондрію (хвороба близьких). Чітко простежується зростання дратівливості в процесі втомлення.

Сенситивний тип (С). З дитинства лякливі та боязкі. Часто бояться темряви, залишатися наодинці, уникають тварин. Уникають жвавих і гучних однолітків. Сором'язливі і замкнуті серед сторонніх, у незвичайному оточенні. Люблять грати з малюками, відчуваючи себе з ними впевненіше та спокійніше. Відрізняються слухняністю, вважаються «домашніми дітьми». Школа їх лякає шумом, метушнею та бійками на перервах. Вчаться зазвичай

старанно. Бояться різного роду контрольних, перевірок, екзаменів. Часто соромляться відповідати біля дошки, бояться прослити вискочкою. Початок пубертатного періоду зазвичай проходить без особливих ускладнень. Труднощі починаються з 16 років. Тут особливо яскраво виступають дві головні риси – велика вразливість і відчуття власної неповноцінності. У собі бачать безліч недоліків, особливо в області якостей морально-етичних та вольових. До рідних зберігається дитяча прихильність. Опіці близьких охоче підкоряються. Докори та покарання з їхнього боку викликають сльози та відчай. Рано формується відчуття обов'язку, відповідальності, високих, іноді надмірних моральних вимог до себе та оточуючих. Брехати та прикидатися не люблять і не вміють. Відмові відповідати віддають перевагу неправді. Непосильною є ситуація, коли сенситив опиняється об'єктом неблаговоління оточуючих, коли на його репутацію падає тінь або він піддається несправедливим звинуваченням. Ні до алкоголізації, ні до делинквентності не виявляють схильності. Самооцінка відрізняється досить високим рівнем об'єктивності.

Місце найменшого спротиву: Ахіллесовою п'ятою сенситивного типу є ставлення до них оточуючих. Нестерпною для них виявляється ситуація, де вони стають об'єктом насмішок або підозри у неблаговидних вчинках, коли на їхню репутацію падає найменша тінь або коли їх піддають несправедливим звинуваченням.

Психастенічний тип (П). Прояви в дитинстві можуть бути незначними у вигляді сором'язливості, лякливості, рухової незграбності та ранніх не за віком «інтелектуальних» інтересів. Іноді вже в дитинстві виявляються нав'язливі особливості у вигляді побоювань і страхів – фобій: страху незнайомих людей, нових предметів, темряви та ін. Критичним періодом, коли риси цього типу характеру зазвичай виявляються, є початкові класи школи – при перших вимогах до відчуття відповідальності. Відповідати за себе і особливо за інших представляє один з найбільш чутливих ударів для психастенічної натури. У пубертатному віці різких загострень зазвичай не буває. Психастенічні риси можуть навіть дещо згладжуватися. Основними рисами психастенічного типу є нерішучість, схильність до роздумів, тривожна підозрілість у вигляді побоювань за майбутнє – своє та своїх близьких, любов до самоаналізу, самокопання та легкість виникнення нав'язливих страхів, побоювань, ритуалів, думок. Захистом від постійної тривоги через уявлені неприємності та нещастя служать вигадані забобони та ритуали. Наприклад, виходячи з дому, переступати поріг тільки правою ногою. Нерішучість особливо проявляється, коли треба зробити самостійний вибір. Спостерігається реакція гіперкомпенсації стосовно своєї нерішучості та невпевненості, яка проявляється в несподіваних самовпевнених, безапеляційних судженнях, в перебільшеній рішучості та поспішних діях у моменти, коли потрібна неквапліва обережність та обачність. Зазнавши невдач, ще більше посилюють нерішучість та сумнів. Підліткова реакція емансипації виражена слабо і не рідко заміщена патологічною прихильністю до когось із членів сім'ї. Алкоголізація та делинквентність не притаманні. Самооцінка не завжди відрізняється правильністю, зустрічається тенденція знаходити у себе риси різних типів, включаючи не властиві, наприклад істеричні.

Місце найменшого спротиву: Ахілесовою п’ятою є моменти особливо високих вимог до почуття відповідальності, наприклад під час іспитів.

Шизоїдний тип (Ш). З дитячих років дивують тим, що люблять грати самі, уникають метушні та гучних забав, віддають перевагу товариству дорослих, довго мовчки слухають їхні розмови. До цього додається якась недитяча холодність та стриманість. У підлітковому віці всі риси шизоїдного типу крайньо загострюються. Кидається в очі замкнутість, відгородженість від однолітків. Важко встановлюють неформальні, емоційні контакти – ця неспроможність тяжко переживається. Швидка виснажливість у контакті спонукає до ще більшого занурення в себе. Недолік інтуїції проявляється невмінням зрозуміти чужі переживання, вгадати бажання інших, здогадатися про невисловлене вголос. До цього приєднується недолік співпереживання. Внутрішній світ майже завжди закритий для інших і заповнений захопленнями та фантазіями, які призначені тільки для задоволення самого себе, служать втіхою амбіціям або мають еротичний характер. Еротичні фантазії поєднуються з зовнішньою сексуальністю. Недоступність внутрішнього світу та стриманість у прояві почуттів роблять вчинки шизоїдів незрозумілими та несподіваними для оточуючих, адже весь хід попередніх переживань та мотивів залишається прихованим. Їхні дивацтва несподівані, але не служать меті привернути до себе увагу. Підліткова реакція емансипації зазвичай проявляється дуже своєрідно. Шизоїд терпить дріб'язкову опіку в побуті, здатний підкоритися встановленому порядку та режиму, але готовий реагувати бурхливим протестом на найменшу спробу вторгнутися без дозволу в світ його інтересів, захоплень та фантазій. Може проявлятися соціальна нонконформність – обурення з приводу існуючих правил та законів, насмішки над поширеними ідеалами, інтересами та духовними цінностями. Такі судження можуть довго таємно виношуватися та несподівано для всіх реалізовуватися у рішучих діях або публічних виступах, без урахування наслідків для себе. Захоплення відрізняються силою, постійністю та часто незвичністю, вишуканістю. Предметом захоплень можуть стати: китайські ієрогліфи, давньоєврейська мова, порівняння конституцій різних держав та часів, колекція малюнків церков та соборів і т.д. Захоплення часто приховують, боячись нерозуміння та насмішок. Також зустрічаються хобі мануально-тілесного типу. У спорті віддають перевагу гімнастиці, плаванню, велосипеду, але не командним іграм. Алкоголізація та делінквентність зустрічаються нечасто. Самооцінка відрізняється вибірковістю: добре констатується замкнутість, труднощі контактів, нерозуміння оточуючих, інші особливості помічаються гірше. Іноді підкреслюється нонконформізм.

***Місце найменшого спротиву*:** проявляється коли необхідно швидко встановити широке коло неформальних і достатньо емоційних контактів. Шизоїди також зриваються, коли до них наполегливо і безцеремонно «лізуть в душу».

Епілептоїдний тип (Е). Лише в частині випадків риси цього типу починають проявлятися в дитинстві. Така дитина може годинами плакати, і її неможливо ні втішити, ні відвернути. Поряд з цим виявляються садистичні схильності – люблять мучити тварин, дражнити молодших і слабших, знущатися над безпомічними та неспроможними дати відсіч. Відзначається також недитяча бережливість одягу, іграшок, всього «свого», крайня злобна реакція на всіх, хто намагається посягнути на їхню дитячу власність. З перших шкільних

років виступає дріб'язкова скрупульозність та підвищена акуратність у веденні зошитів, всього учнівського господарства. У більшості випадків риси епілептоїдного характеру виступають лише у підлітковому віці. Головною рисою цього типу є схильність до виникнення періодів злобного настрою з поступово накопичуваним роздратуванням та пошуком об'єкта, на якому можна було б виплеснути зло. З цим зазвичай пов'язана афективна вибуховість. Афекти не тільки сильні, але й тривалі. У афекті може виступати безмежна лють – цинічна лайка, жорстокі побиття, байдужість до слабкості та безпомічності противника та неспроможність врахувати його переважаючу силу. Любов майже завжди забарвлена ревнощами. Алкогольні сп'яніння часто протікають важко – з гнівом та агресією. Лідерство проявляється прагненням володарювати над однолітками. Непогано адаптуються в умовах строгого дисциплінарного режиму, де прагнуть підлеститися до начальства показною виконавчістю та заволодіти положенням, що дає владу над іншими підлітками. Інертність, в'язкість залишають відбиток на всій психіці – від моторики та емоцій до мислення та особистісних цінностей. Дріб'язкова акуратність, скрупульозність, педантичне дотримання всіх правил, навіть на шкоду справі, педантизм зазвичай розглядаються як спосіб компенсації власної інертності. Реакція емансипації не рідко протікає важко. Від рідних вимагається не тільки «свобода», самостійність, але й «права», частка майна, житла, матеріальні блага. Серед захоплень слід зазначити схильність до азартних ігор. Легко пробуджується майже інстинктивне прагнення до збагачення. Колекціонування приваблює матеріальною цінністю зібраного. Самооцінка зазвичай однобока: відзначається прихильність до порядку та акуратності, нелюбов до порожніх мрій та перевага жити реальним життям; у всьому іншому представляють себе набагато більш конформними, ніж є насправді.

Місце найменшого спротиву: Ситуації де потрібна гнучкість характеру і вміння підлаштовуватись.

Істероїдний тип (І). Риси істероїдного типу часто проглядаються з дитячих років. Такі діти не виносять, коли при них хвалять інших дітей, іншим приділяють увагу. Іграшки їм швидко набридають, охоче декламують вірші, танцюють, співають, виступають з метою привернути до себе увагу, щоб слухати захоплення та похвали. Основними рисами є безмежний егоцентризм, ненаситне бажання постійної уваги до своєї особи, захоплення, співчуття. Всі інші особливості живляться цим. Зовнішні прояви емоційності на ділі обертаються відсутністю глибоких почуттів при великій виразності, театральності переживань, схильності до рисовки та позерства. У підлітковому віці для привернення до себе уваги можуть використовуватися порушення поведінки: пияцтво, крадіжки, асоціальні компанії. Делинквентність зазвичай зводиться до прогулів, небажання вчитися та працювати. Схильні до провокаційної поведінки у громадських місцях. Більш тяжких порушень зазвичай уникають. Нездатність до наполегливої праці поєднується з високими претензіями щодо майбутньої професії. Реакція емансипації може мати бурхливі зовнішні прояви – втечі з дому, конфлікти, вимоги свободи тощо. Насправді справжньої свободи та самостійності не шукають – від уваги та турботи близьких зовсім не прагнуть позбутися. Серед однолітків претендують на першість або на виняткове становище. Намагаються піднятися серед них

розповідями про свої успіхи та пригоди. Товариші швидко розпізнають їхні вигадки, їхню ненадійність, тому вони часто міняють компанії. Самооцінка далека від об'єктивності. Зазвичай представляють себе такими, якими в даний момент легше всього справити враження.

***Місце найменшого спротиву*:** Слід підкреслити, що слабкою ланкою істероїдного типу, удар по якій може виявити істероїдні риси при прихованій акцентуації або зумовити яскраву істеричну реакцію при акцентуації явній, найчастіше бувають утиснене самолюбство, втрата уваги оточення або особливо значущих осіб, крах надій на престижне становище, розвінчана винятковість.

Нестійкий тип (Н). У дитинстві відрізняються непослухом, неспокоєм, всюди і в усе лізуть, але при цьому боягузливі, бояться покарань, легко підкоряються іншим дітям. Елементарні правила поведінки важко засвоюються. За ними постійно доводиться стежити. Головна риса – небажання працювати – ні працювати, ні вчитися, яка починає проявлятися з перших класів школи. Постійне сильне бажання розваг, задоволення, ліні. Охоче наслідують тим, чия поведінка обіцяє насолоди, розваги, зміну легких вражень. При суворому та безперервному контролі неохоче підкорюються, але завжди шукають нагоду уникнути занять. Повна відсутність волі, коли справа стосується виконання обов'язків, досягнення цілей, які ставлять перед ними рідні, старші, суспільство в цілому. Від будь-яких труднощів та неприємностей намагаються втекти та не думати про них. Порушення поведінки, делінквентність, рання алкоголізація перш за все зумовлені бажанням розважитися. Ще дітьми починають курити. Легко йдуть на дрібні крадіжки. Тягнуться до вуличних компаній. Через боягузтво та недостатню ініціативність опиняються там у підлеглому становищі. Контакти завжди поверхневі. Весела компанія завжди важливіша за відданого друга. Реакція емансипації тісно пов'язана з тими ж бажаннями задоволення та розваг. Глибокої любові до батьків вони не відчувають. Рідні для них – перш за все джерело для насолод. Романтична закоханість їм не властива, раннє сексуальне життя служить джерелом насолоди. Слабкість волі та боягузтво дозволяють утримувати їх в умовах дисциплінарного режиму. Безнаглядність швидко чинить руйнівну дію. Самооцінка зазвичай неправильна – легко приписує собі гіпертимні або конформні риси.

***Місце найменшого спротиву*:** Слабке місце нестійких — безнадзорність, обстановка поблажливості, що відкриває простори для ліні та бездіяльності.

Конформний тип (К). Головна риса – постійна та надмірна конформність до звичного оточення і свого середовища. Живуть за правилом: думати «як всі», діяти «як всі», намагатися, щоб у них було «як у всіх» - від одягу до суджень за життєво важливими питаннями. Становляться цілком продуктом свого оточення: у хороших умовах старанно вчаться та працюють, у поганому середовищі – міцно засвоюють його звичаї, звички, манеру поведінки. Адаптація до нового середовища відбувається у них повільно та спочатку важко, але коли вона вже здійснилася, нове середовище стає таким самим диктатором

поведінки, як раніше було попереднє. Тому «за компанію» легко пиячать, можуть бути втягнуті у групові правопорушення. Конформність поєднується з дивовижною некритичністю: за істину вважають те, що надходить через звичний канал інформації. До цього додається консерватизм: нове не люблять тому, що не можуть до нього швидко пристосуватися, важко освоюються в незвичному оточенні. Найуспішніше працюють, коли не вимагається особистої ініціативи. Погано переносять ломку життєвого стереотипу, позбавлення звичного товариства. Дитинство під опікою дорослих не дає надмірних навантажень для конформного типу. Тому лише у підлітковому віці починають виявлятися конформні риси. Самооцінка може бути непоганою. Більшість правильно відзначає основні риси свого характеру.

Місце найменшого спротиву: Якщо ситуація вимагає ініціативності, вони дають збій на будь-якій, навіть найнезначнішій посаді, витримуючи набагато більш висококваліфіковану і навіть вимагаючу постійного напруження роботу, якщо вона чітко регламентована і заздалегідь відомо, що треба робити в кожній ситуації.

Ситуації де звична соціальна група з якоїсь причини виганяє їх. Надмірна піддатливість впливу оточення та надмірна прив'язаність до всього звичного. Реакція емансипації яскраво виявляється лише у випадку, коли батьки, педагоги, старші відірвали конформного від звичайного для нього оточення, коли вони протистоять його бажанню бути "як усі", перейняти поширення в його групі моди, захоплення, манери, наміри.

Параноїдний тип у підлітковому віці ще не проявляється — його розквіт припадає на пік соціальної зрілості, тобто на 30–40 років. Тому за допомогою ПДО цей тип діагностувати неможливо. У підлітковому віці майбутні представники параноїдного типу найчастіше виявляють епілептоїдну або шизоїдну акцентуацію, рідше істероїдну і ще рідше — гіпертимну. Однак уже в цьому віці може виявлятися завищена оцінка власної особистості — своїх здібностей, своїх талантів і вмінь, своєї мудрості та розуміння всього. Звідси переконаність, що все, що вони роблять, завжди правильно, що думають і говорять — завжди істина, на що претендують — безумовно мають право. Будь-які перешкоди на шляху втілення в життя своїх намірів пробуджують войовничу готовність захищати свої дійсні або уявні права. Рано пробуджується підозрілість, схильність всюди бачити злий умисел та змову проти себе.

V. Заключення

За шкалою об'єктивної оцінки діагностований істероїдний тип акцентуації. Показник Дп (2 пункти), вказує на ризик депресії.

"Слабким місцем" даного типу є втрата уваги оточення або особливо значущих осіб, крах надій, моменти особливо високих вимог до почуття відповідальності, наприклад під час іспитів.

VI. Рекомендації

Прочитати опис кожної акцентуації, особливо І, П. Підкреслити та запам’ятати, що притаманно, а що ні. Пробувати помічати притаманні особливості в повсякденному житті. (Якою акцентуацією я пред’являюсь людям в даний момент? Чи хочу я зараз цією акцентуацією пред’являтись? Чи можу переключатись на іншу акцентуацію в процесі? Як це впливає на інших та на мене?)

Напрацювати механізми компенсації (полегшення впливу), при ситуаціях невдачі або втрати уваги від значущих людей (друзі, рідні, стосунки). Спостерігати за своїми відчуттями в моменти гострої критики зі сторони значимих людей. Не давати себе втягувати в токсичні взаємодії (де відбувається не справедлива критика). Спостерігати за реакціями коли наближається відповідальна подія або потрібно прийняти рішення по важливих проблемах.